DB

青 岛 市 服 务 业 标 准 规 范

DB 3702/ FW HLBX 006-2020

长期护理保险定点护理服务机构照护服务管理规范

Management Standards for Care Services of Long-term Care Insurance Designated Care Service

2020 -05-29 发布　　2020-06-01 实施

青 岛 市 医 疗 保 障 局　发布
青岛市市场监督管理局

目　　次

前　　言.....2
引　　言.....3
1 范围.....4
2 规范性引用文件.....4
3 术语和定义.....4
4 人员要求.....4
5 服务管理制度.....5
6 机构照护服务.....5
7 居家照护服务.....6
8 服务质量评价与改进.....6
9 工作流程图.....7
附录 A.....8
附录 B.....10
附录 C.....11
附录 D.....12

前　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由青岛市医疗保障局提出并归口。

本标准起草单位：青岛市医疗保障事业中心、中国社会保险学会社会保险管理服务专业委员会、山东工商学院。

本标准主要起草人：马青、龚忆莼、李静、张秋立、唐林凤、邓玉华、林君丽、刘湘源、刘楠、孙源、姜日进、谭美青、张志勤、孙渊、王圆、王莹、刘序田、朱红燕、纪斌 。

引　　言

本标准是《长期护理保险管理与服务》标准体系系列之一，旨在规范完善长期护理保险定点护理服务机构照护服务,提高定点护理服务机构照护服务管理水平,满足参保人多元化服务需求,促进长期护理保险健康可持续发展。

长期护理保险定点护理服务机构照护服务管理规范

1 范围

本标准规定了长期护理保险定点护理服务机构（以下简称“定点护理机构”）的人员要求、服务管理制度、机构照护服务、居家照护服务以及服务质量评价与改进等要求。

本标准适用于青岛市行政区内的定点护理机构服务规范管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35796-2017 养老机构服务质量基本规范

DB 37/T 2891-2016 山东省养老服务基本术语

DB/Z 1-2018 医养结合服务基本规范

DB3702/FW HLBX001-2019 长期护理保险管理与服务 总则

3 术语和定义

DB3702/FW HLBX001-2019 界定的术语和定义，以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

长期护理保险护理员 Long-term Care Insurance Carer

在定点护理机构为照护对象提供照料、护理的服务人员（以下简称“护理员”）。

注：改写 DB 37/T 2891-2016，4.1

3.2

失智专区 Memory care area

在定点护理机构设立的专业照护失智人员的区域。

4 人员要求

4.1 管理人员应具备养老服务组织或医疗机构的管理经验，并在任职前经过岗前培训。

4.2 执业医生和执业护士应持有相关部门颁发的执业资格证书，并符合相关国家规定和行业规范对执业资质的要求。

4.3 康复人员、营养师、社工人员、心理工作者等相关服务人员应持有国家认可的资格证书，并经过长期护理保险相关的专业培训。

4.4 护理员应经过专业的培训，并取得相应的职业资格证书。

4.5 失智专区的护理员应经过失智人员照护专业培训，并取得职业资格证书或培训结业证书。

4.6 会计人员应具备从事会计工作所需要的专业能力，取得相关会计资格证书，会使用会计电算化。

4.7 药品管理人员应取得相关资格证书，会使用药品管理系统软件。

5 服务管理制度

5.1 定点护理机构应建立照护对象综合评估制度。通过对照护对象进行全面综合评估，明确照护对象主要的健康问题和护理服务需求。综合评估结果作为定点护理机构为照护对象制定个性化护理服务计划的重要依据。

5.2 定点护理机构应根据本机构护理服务的实际情况，制定照护人员岗位职责，包括但不限于执业医师、执业护士、护理员、康复人员、社工人员、营养师、心理工作者等。

5.3 定点护理机构应建立照护人员交接班制度。交接班应采用集体交班、床头交班、口头交班、书面交班等形式。交接班内容包括但不限于照护对象的基本信息、病情变化、执行医嘱情况、药品物品交接、特殊情况等。

6 机构照护服务

6.1 综合评估

6.1.1 定点护理机构应安排责任护士按规定对入住的照护对象进行综合评估，明确照护对象的健康状况和照护服务需求。

6.1.2 综合评估内容应包括但不限于：照护对象基本信息、既往史、过敏史、家族史、生活状况、生命体征、心理社会状态（如情绪、思维等）、跌倒风险（如自理能力、肢体活动、跌倒史等）、压疮风险、各系统状态、置管与治疗情况（如胃管、尿管、造瘘管等）、家庭、社会支持系统情况等。

6.1.3 因病情变化而住院治疗的照护对象，出院后需继续照护的应再次进行综合评估，并依据评估结果适当调整照护计划。

6.2 制定个性化照护计划

定点护理机构应根据照护对象的综合评估情况，制定个性化照护计划，计划内容包括但不限于：医疗护理、生活照料、功能维护（康复训练）、心理支持及精神慰藉等。在责任护士主导下，有关照护人员、照护对象及家属等应共同参与制定照护计划。

6.3 实施照护计划

照护人员应了解并熟悉机构照护对象的基本信息、基础情况、照护计划等信息，应着装整洁、正确佩戴工作牌，行为举止应符合礼仪规范，使用文明用语，规范实施照护计划，规范操作，按要求做好记录。

6.4 照护效果评价

定点护理机构应及时组织照护服务情况与效果的评价，将评估结果告知照护对象或家属，及时调整和完善照护服务内容及计划。

7 居家照护服务

7.1 综合评估

7.1.1 定点护理机构应安排责任护士按规定对居家照护对象进行综合评估，明确照护对象的健康状况和照护服务需求。

7.1.2 综合评估内容应在本标准 6.1 的基础上，对居家照护环境及其家庭照料者进行评估。

7.2 制定个性化照护计划

见本标准 6.2。

7.3 实施照护计划

7.3.1 预约

照护人员应提前了解并熟悉居家照护对象的基本信息、基础情况、照护计划等，根据照护计划安排，预约上门时间。因故未能按照预约时间进行服务或确需调换照护人员，应提前告知，并重新预约服务时间。

7.3.2 入户准备

照护人员出发前，应详细检查所需携带的证件、服务单、药品、用物以及其他必需物品是否齐全，并提前合理确定前往照护对象家中的路线和方式。

7.3.3 入户

照护人员应征得家属同意后方可入户，首次入户时不少于两人同时进入。应着装整洁、出示工作牌，行为举止应符合礼仪规范，使用文明用语。入户后应合适摆放所携物品，登陆手机 “移动医疗护理”APP。

7.3.4 实施照护

7.3.4.1 照护人员在实施照护前，应向照护对象及家属了解近期身体状况和服务需求，确认服务内容，征得同意后实施照护。

7.3.4.2 照护人员应按照护计划规范操作，随时观察照护对象的变化。照护对象出现身体不适时，应立即停止操作，并按要求做好记录。对异性照护对象需暴露隐私部位时，应有家属或另一名照护人员在场。

7.3.4.3 照护人员完成服务后，应按规定将服务信息上传“移动医疗护理”APP，做好医疗垃圾的回收整理，并告知照护对象及家属有关注意事项，必要时应传授其相关照护知识。

7.3.4.4 照护人员应及时征求照护对象及家属的意见和建议，与照护对象及家属约定下次上门服务的时间。

7.4 照护效果评价

见本标准 6.4。《照护对象综合评估表》见附录 A，《照护计划与评价表》见附录 B。

8 服务质量评价与改进

8.1 定点护理机构应建立服务满意度评价机制，通过问卷调查、电话随访、投诉举报等形式，及时了解照护对象及家属对服务质量的评价与意见。《定点护理机构照护服务照护对象或家属满意度评价表》见附录 C。

8.2 定点护理机构应根据满意度反馈情况，开展服务质量考核和评价工作。开展服务质量评价的方式包括但不限于机构内部组织评价考核、邀请第三方专业机构开展服务评价等。

8.3 定点护理机构对满意度调查和质量评价过程中发现的问题，应及时提出改进措施，确保措施落实，持续提高服务质量，优化服务流程。

8.4 评价与改进的相关记录应纳入本机构的档案管理。

9 工作流程图

《定点护理机构服务管理流程图》见附录 D。

附录 A

（规范性附录）

照护对象综合评估表

单位名称　　科别　　病历号　　个人编号　　身份证号

一、基本情况评估

姓名	性别	年龄	文化程度
民族	籍贯	婚姻	执业医师
职业	联系人	联系电话	执业护士
医疗诊断		日常生活能力评定评分	家庭住址
审批通过		收集资料时间	

既往史：☐无　☐有（高血压、冠心病、糖尿病、脑卒中、肺结核、精神病、肿瘤、其它_____）

过敏史：☐无　☐有（药物 _____；食物_____；其它_____）

家族史：☐无　☐有（高血压、冠心病、糖尿病、精神病、 肿瘤、癫痫、传染病、遗传病、其它 _____）

二、生活状况评估

1．饮食：☐普食　☐软食　☐半流质　☐流汁　☐禁食　☐管饲　☐其它

2．睡眠：☐正常　☐异常（入睡困难、多梦、早醒、失眠、药物辅助、其它）

3．排泄

（1）排便：☐正常　☐便秘　☐腹泻　☐失禁　☐造瘘（自理：能　不能）　☐其它

（2）排尿：☐正常　☐尿失禁　☐尿潴留　☐排尿困难　☐留置尿管　☐其它

4．体位：☐主动体位 ☐被动体位 ☐被迫体位（半坐卧位、端坐位、俯卧位、其它）

5．嗜好：☐吸烟　☐饮酒　☐喜咸　☐喜甜 ☐喜辛辣　☐喜油腻　☐其它

（1）吸烟：☐无　☐偶尔　☐经常（　年，　支/日，已戒烟　年）　☐其它

（2）饮酒：☐无　☐偶尔　☐经常（　年，　两/日）　☐其它

6．其它

三、生命体征评估

1．体温：　　℃（口温、腋温、直肠温度、其它）

2．脉搏（心率）：　　次/分（律齐、早搏、绌脉、其它）

3．呼吸：☐规则（　　次/分）　☐不规则（喘息样、抽泣样、叹息样、其它）

4．血压：　　mmHg

四、心理社会评估

1. 情绪：□镇静 □易激动 □焦虑 □恐惧 □悲哀 □无反应 □其它
2. 思维过程：□正常 □注意力分散 □远/近期记忆力下降 □思维混乱 □其它
3. 与亲友关系：□和睦 □冷淡 □紧张 □其它
4. 就业状态：□固定职业 □丧失劳动能力 □失业 □待业 □退休 □其它
5. 居住：□独居 □与配偶同住 □与子女同住 □与亲戚同住 □其它
6. 医疗费来源：□医保 □自费 □其它

五、跌倒风险评估

1. 肢体活动：□正常 □活动障碍（左/右偏瘫、截瘫、全瘫、其它）
2. 使用辅助用具：□无 □拐杖 □轮椅 □助行器 □义肢 □其它
3. 疼痛：□无 □有（部位： ，程度：轻微痛、较痛、剧痛）
4. 视力：□正常 □戴眼镜 □视力模糊 □青光眼 □视觉障碍 □失明 □其它
5. 听力：□正常 □耳鸣 □听力下降（左/右） □耳聋（左/右） □助听器 □其它
6. 跌倒史：□无 □有（偶尔、经常）
7. 其它：□药物/乙醇戒断 □骨折史 □严重骨质疏松 □缺氧症 □其它

六、体格检查

1. 皮肤粘膜
   （1）皮肤颜色：□正常 □潮红 □苍白 □发绀 □黄染 □其它
   （2）皮肤温度：□正常 □干燥 □潮湿 □多汗 □其它
   （3）皮肤完整性：□完整 □皮疹 □出血点 □压疮（$Ⅰ^0$、$Ⅱ^0$、$Ⅲ^0$，部位_____，大小_____cm） □其它
   （4）口腔粘膜：□正常 □充血 □白斑 □溃疡 □糜烂 □其它
2. 腹部检查：□平软 □肌紧张 □压痛/反跳痛 □可触及包块（部位及性质_____） □腹胀 □腹水（腹围_____cm）
3. 神经系统
   （1）意识：□清楚 □嗜睡 □模糊 □昏睡 □谵妄 □昏迷（浅昏迷、 深昏迷）
   （2）沟通：□正常 □表达困难 □语言障碍 □失语 □其它
   （3）定向力：□准确 □障碍（自我、时间、地点、人物）
4. 呼吸系统
   （1）呼吸方式：□自主呼吸 □辅助呼吸 □机械通气
   （2）症状：□咳嗽 □咳痰（粘痰、黄痰、脓痰、铁锈色痰、红色痰）□其它
5. 循环系统：□心悸 □胸闷 □胸痛（针刺样、压榨样、烧灼样、其它） □水肿（凹陷性、 非凹陷性） □晕厥（偶尔、经常） □紫绀（部位_____） □其它
6. 消化系统：□恶心 □呕吐（ 次/天 总量 ml） □暖气 □反酸 □烧灼感 □其它
7. 外阴、生殖系统
   （1）女性：□外阴（正常 瘙痒 白斑 其它）□生殖系统（月经紊乱 痛经 月经量 过 多/过少 白带异常 已绝经 其它）
   （2）男性：□外阴（正常 瘙痒 白斑 其它） □生殖系统（前列腺增生 前列腺炎 前列腺钙化 前列腺囊肿 其它）

七、置管与治疗

□鼻胃管 □留置尿管 □气管插管 □造瘘管 □膀胱冲洗/滴药 □肛管排气 □其它

八、补充说明

评估时间：
责任护士签名：
照护对象或家属签字：

附录 B

（规范性附录）

照 护 计 划 与 评 价 表

姓名：　　个人编号：　　年龄：　　性别：　　诊断：　　□职工　□居民

日期／时间	主 要 照 护 问 题	预 期 目 标	照 护 措 施	照护服务时间、频次	照护人员签名	照护对象或家属签名	照护计划评价			
							日期 时间	计划完成情况	照护人员签名	责任护士签名

附录 C

（规范性附录）

定点护理机构照护服务

照护对象或家属满意度评价表

机构名称：				
满意度情况：	□非常满意	□满意	□基本满意	□不满意
问题及建议：				
照护对象或家属签名：		时间： 年 月 日		

附录 D
（规范性附录）
定点护理机构服务管理流程图

